

Monique DURAND	ID Patient : DEMO002	0 bilan(s) enregistre(s)
----------------	----------------------	--------------------------

BILAN ACTUEL	
Patient & Biologie renale	Tacrolimus & Ionogramme
Age / Sexe: 63 ans - Femme	Phase post-greffe: > 1 an
Poids: 68.0 kg	C0 residuel: 16.0 ng/mL (Supratherapeutique)
Creatinine: 148.0 umol/L	Cible C0: 5-10 ng/mL
DFG (Cockcroft-Gault): 36.9 mL/min	Dose actuelle: 6.0 mg/j
Stade KDIGO: G3b - Modérée-sévère v	Natremie Na+: 142.0 mmol/L - Normal
	Kaliemie K+: 5.2 mmol/L - Limite haute

Reduction recommandee

3.0 mg/j

1.5 mg matin + 1.5 mg soir (q12h, capsules Prograf)

INTERPRETATION CLINIQUE - JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION
1. Contexte clinique
Patient de 63 ans (Femme), 68.0 kg, greffe cardiaque en phase > 1 an. Fonction renale estimee par Cockcroft-Gault : DFG = 36.9 mL/min, stade KDIGO G3b (Modérée-sévère dim.). C'est ce contexte renal qui conditionne le plafond de dose de tacrolimus.
2. Analyse pharmacocinetique (C0 residuel)
C0 = 16.0 ng/mL est supratherapeutique (cible 5-10 ng/mL). Un taux excessif majore les risques de nephrotoxicite (fibrose interstitielle), de neurotoxicite (tremblements, encephalopathie) et d'infections opportunistes. La reduction est necessaire ; l'ajustement PK proportionnel suggere 3.0 mg/j.
3. Reduction de dose
La dose est reduite de 6.0 mg/j a 3.0 mg/j pour corriger le surdosage et limiter la toxicite, dans le respect du plafond nephroprotecteur de 5.5 mg/j.
4. Conclusion et posologie
Dose recommandee : 3.0 mg/j soit 1.5 mg matin + 1.5 mg soir (q12h, capsules Prograf). Cette posologie represente le meilleur compromis entre l'efficacite immunosuppressive et la preservation de la fonction renale, conformement aux recommandations ISHLT 2016 (Kobashigawa et al., J Heart Lung Transplant) et aux donnees de la litterature.

RAISONNEMENT CLINIQUE ET METHODOLOGIE

1. Cockcroft-Gault (1976)

$$DFG = ((140-63) \times 68.0 \times 0.85) / (0.815 \times 148.0) = 36.9 \text{ mL/min} \Rightarrow \text{G3b}$$

2. Ajustement PK proportionnel (Staatz & Tett, 2004)

$$6.0 \text{ mg/j} \times (7.5 / 16.0) = 2.81 \text{ mg/j} \Rightarrow \text{arrondi capsule } 0.5 \text{ mg} \Rightarrow 3.0 \text{ mg/j}$$

3. Plafond nephroprotecteur (Ojo 2003, Naesens 2009, Ekberg 2007)

$$68.0 \text{ kg} \times 0.1 \text{ mg/kg} \times \text{facteur DFG } 0.8 \text{ (stade G3b)} = 5.5 \text{ mg/j}$$

4. Decision finale

$$\min(\text{PK } 3.0, \text{plafond } 5.5) = 3.0 \text{ mg/j} \Rightarrow 1.5 \text{ mg} \times 2 \text{ /j (q12h)}$$

RESUME DE CONSULTATION - MEDFLOW AI

Patiente de 63 ans (sexe feminin), phase stable (> 1 an post-greffe cardiaque). Le C0 tacrolimus est significativement au-dessus de la cible (16 ng/mL vs cible 5-8 ng/mL), avec une fonction renale modereement alteree (DFG 61 mL/min, stade G2). Une interaction medicamenteuse avec le diltiazem (inhibiteur CYP3A4) est documentee et peut expliquer l'elevation des taux residuels ; la kaliemie est a la limite superieure (5,2 mmol/L). La dose est reduite de 6 mg/j a 5,5 mg/j avec surveillance rapprochee du C0 et de la fonction renale. La discussion concernant l'arret ou la substitution du diltiazem est recommandee avec l'equipe cardiologique.

Genere par MedFlow AI - outil d'aide a la decision

Outil d'aide a la decision clinique - Ne remplace pas la concertation d'equipe de transplantation. Adapter systematiquement au protocole institutionnel. MedFlow AI - Usage professionnel exclusif.

